

Περίπτωση 15η

Άνδρας 67 ετών, με μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα σταδίου IV (μεταστάσεις στο ήπαρ) υπό χημειοθεραπεία, προσέρχεται στο τμήμα επειγόντων περιστατικών αιτιώμενος προοδευτικά επιδεινούμενη καταβολή και αδυναμία.

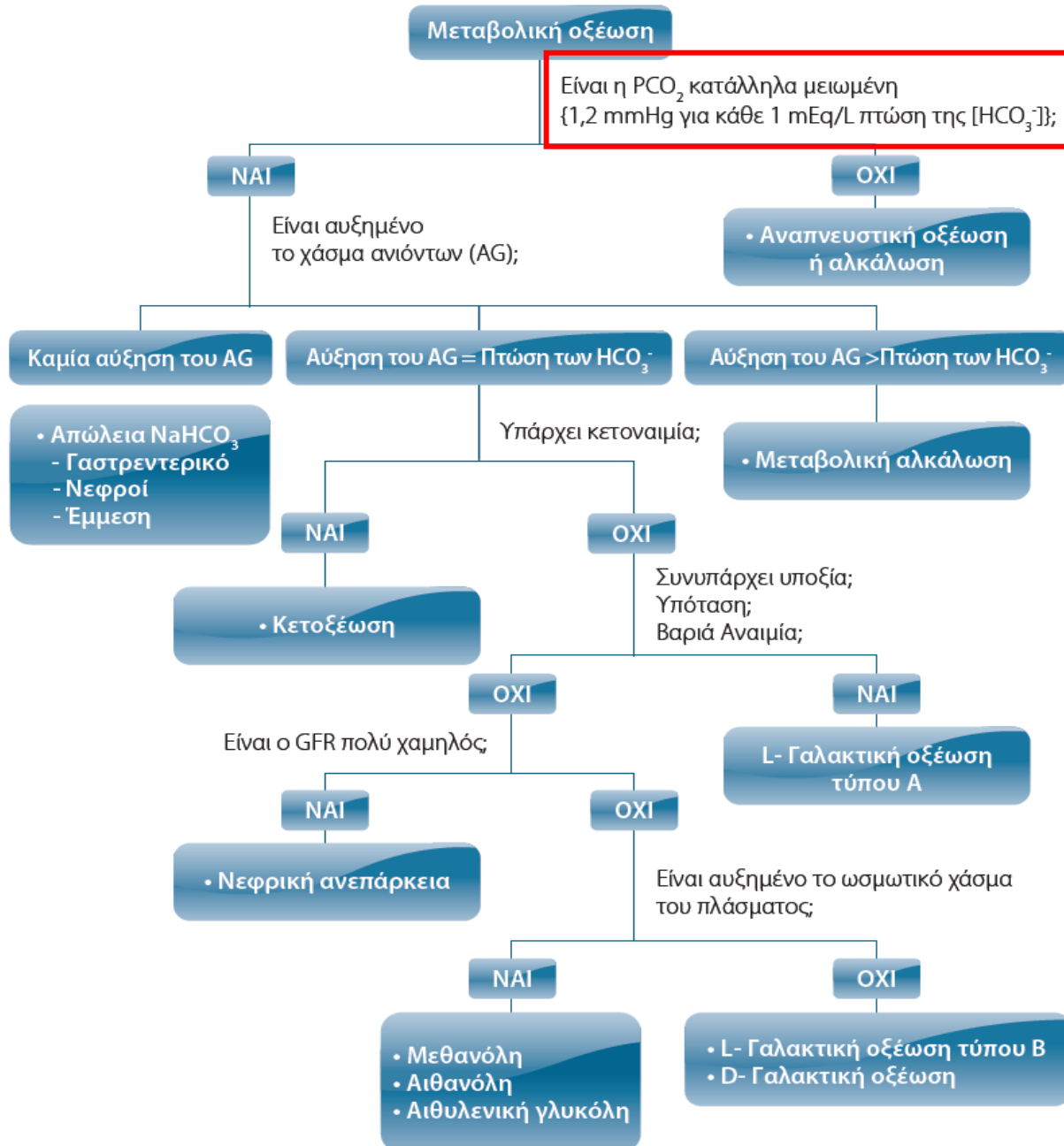
- (FiO₂ 21%)
- PO₂ = 75 mmHg
- PCO₂ = 33 mmHg
- pH = 7.36
- [HCO₃⁻] = 18 mEq/L
- [Na⁺] = 138 mEq/L
- [K⁺] = 4.2 mEq/L
- [Cl⁻] = 102 mEq/L
- [Γλυκόζης] = 94 mg/dl
- [Ουρίας] = 48 mg/dl
- [Κρεατινίνης] = 1.0 mg/dl
- [Γαλακτικού οξέος] = 5.4 mEq/L

Ποια είναι η διαταραχή της οξεοβασικής ισορροπίας;

- α. Αναπνευστική οξέωση
- β. L-γαλακτική οξέωση τύπου B
- γ. L-γαλακτική οξέωση τύπου A
- δ. Μεταβολική οξέωση + αναπνευστική αλκάλωση

- pH = 7.36 (< 7.40)
- $[\text{HCO}_3^-] = 18 \text{ mEq/L}$ (< 24 mEq/L)
- **Μεταβολική οξέωση**

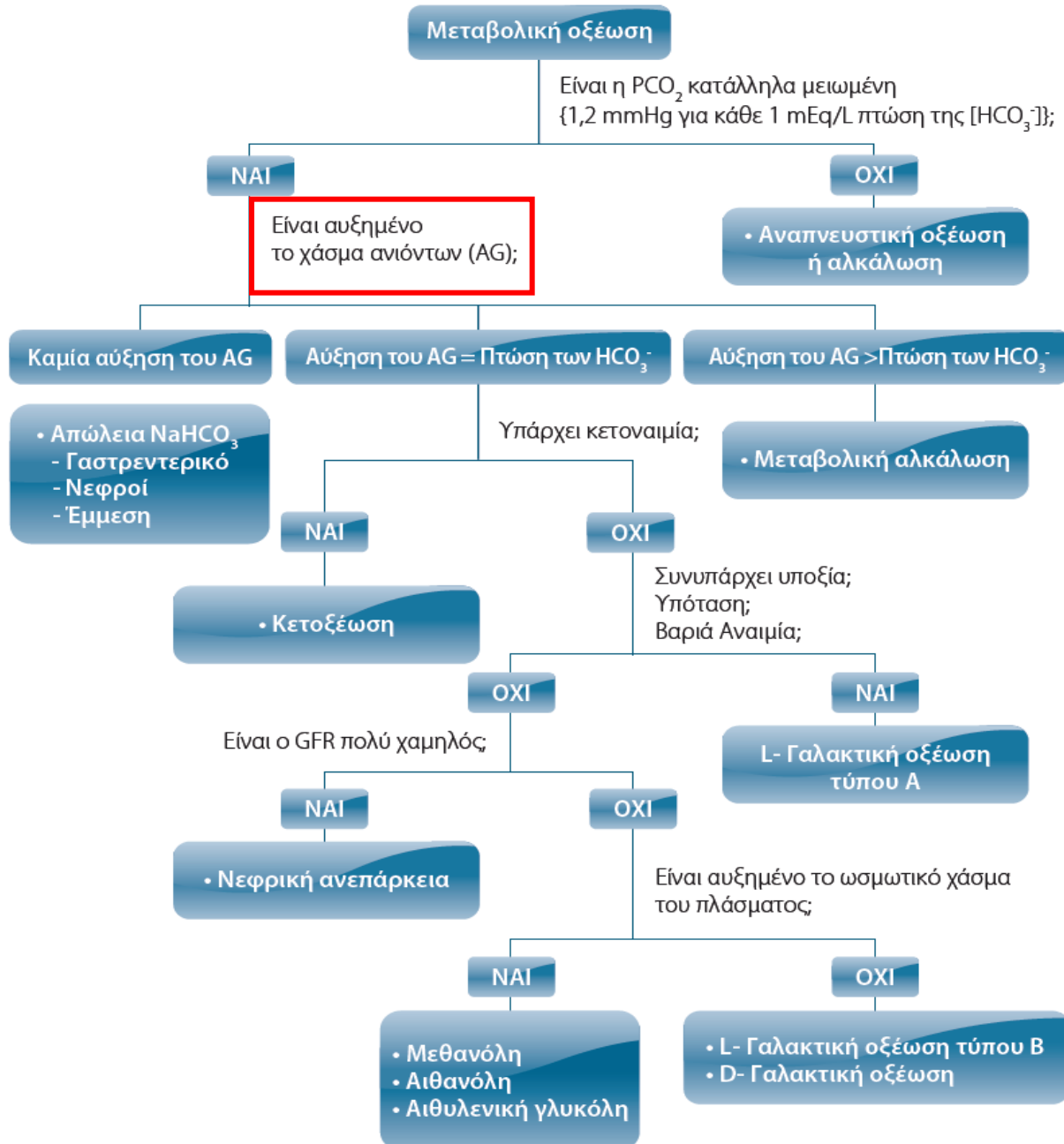
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗΣ ΟΞΕΩΣΗΣ



Είναι αμιγής η μεταβολική οξέωση;

- $[\text{HCO}_3^-] = 18 \text{ mEq/L}$, ↓ κατά 6 mEq/L
- $\text{PCO}_2 = 33 \text{ mmHg}$, αντιστοίχως ↓ κατά $(6 \times 1.2 = 7.2)$ 7 mmHg
- Η PCO_2 ↓ κατά 1.2 mmHg για κάθε 1 mEq/L ↓ της $[\text{HCO}_3^-]$
- **Αμιγής μεταβολική οξέωση**

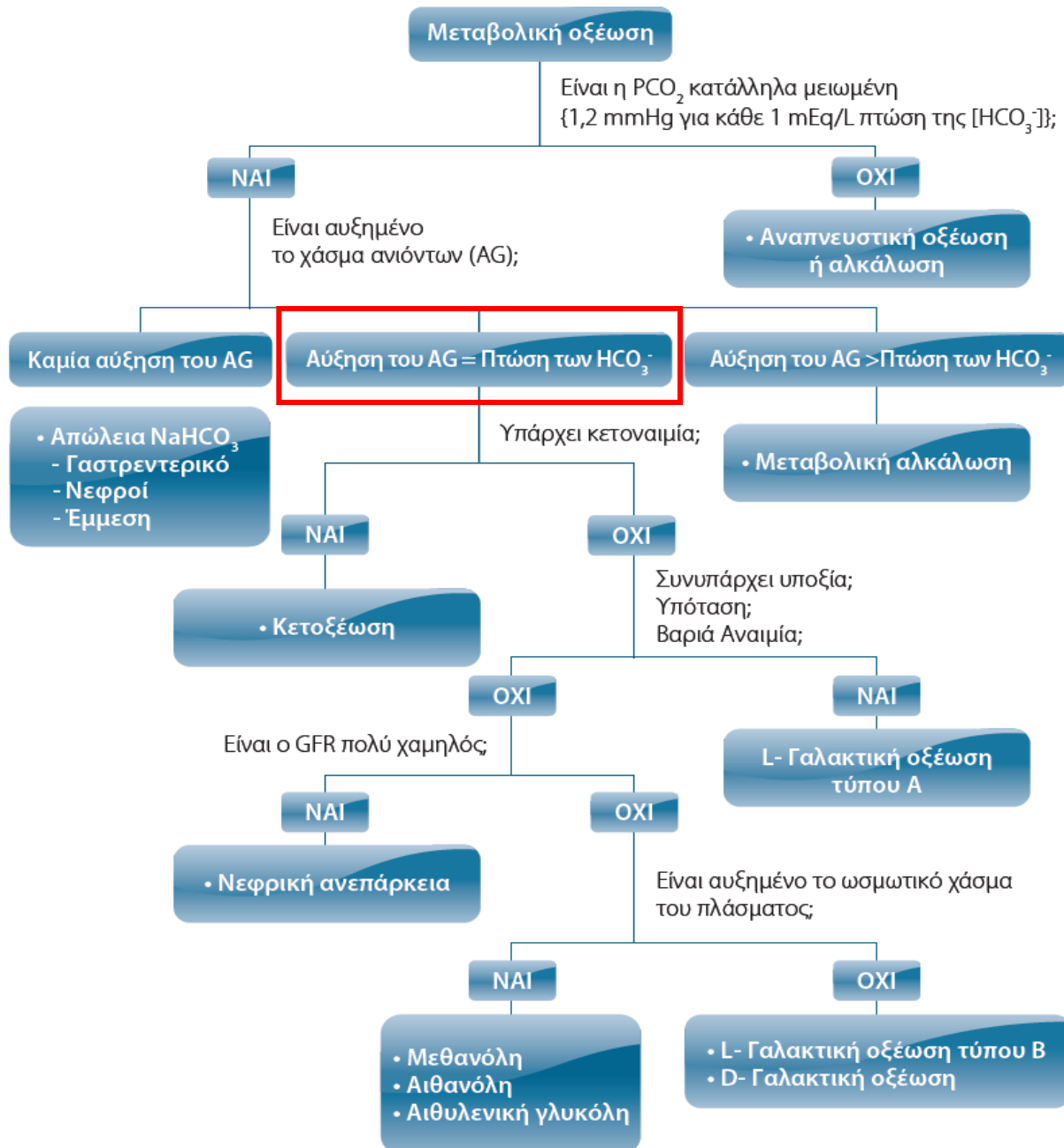
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗΣ ΟΞΕΩΣΗΣ



Είναι ↑ το χάσμα ανιόντων (Anion Gap);

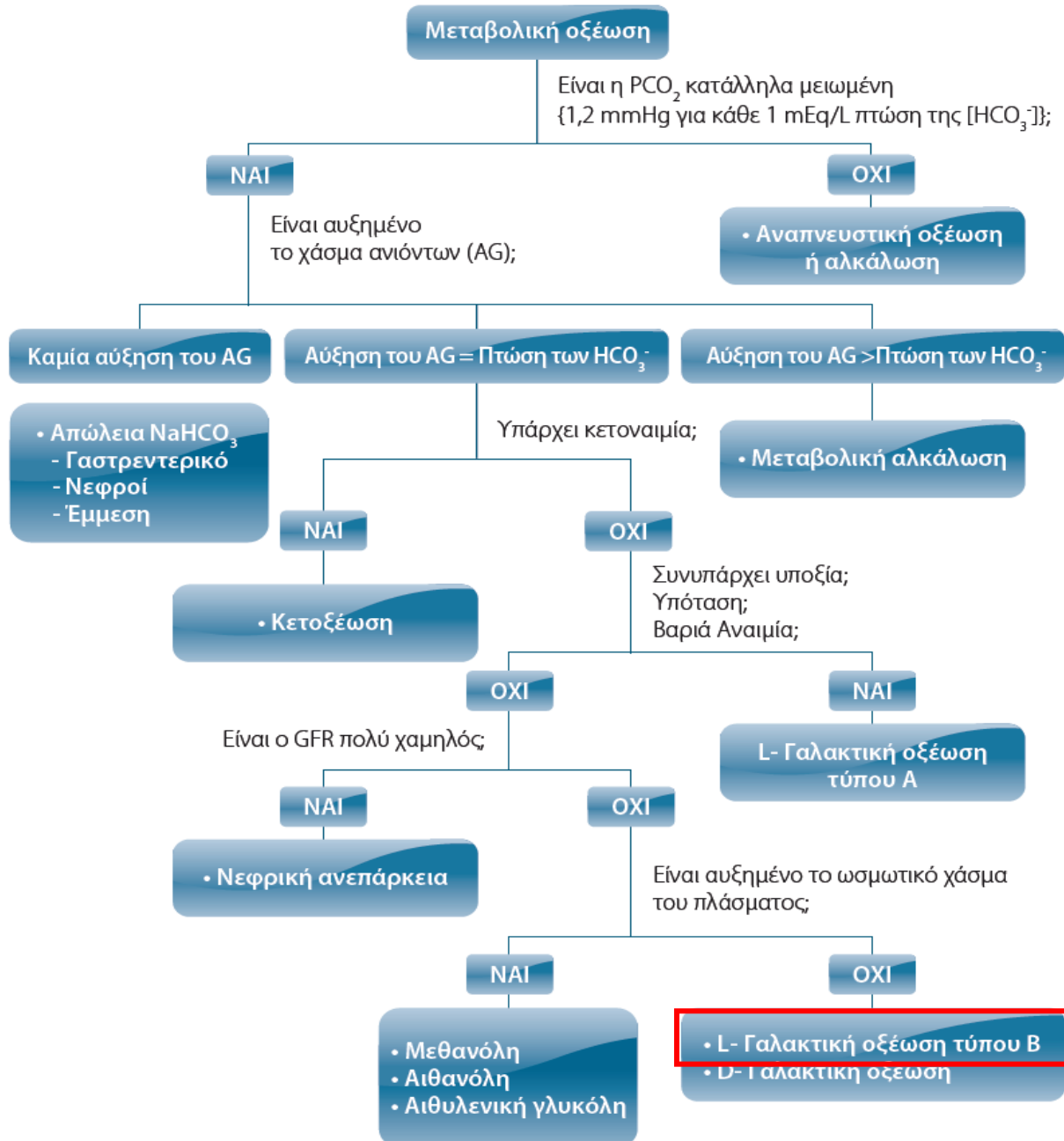
- $AG = [Na^+] - \{[Cl^-] + [HCO_3^-]\} = 138 - (102+18) = 18 \text{ mEq/L}$
- AG ↑ κατά 6 mEq/L
- $[HCO_3^-] = 18 \text{ mEq/L}$, ↓ κατά 6 mEq/L
- Η αύξηση του AG είναι ίση με την πτώση των $[HCO_3^-]$

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗΣ ΟΞΕΩΣΗΣ



- Ο ασθενής δεν εμφανίζει κετοναιμία ή νεφρική ανεπάρκεια
- Μεταβολική οξέωση λόγω $\uparrow$ [Γαλακτικού οξέος] = 5.4 mEq/L

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗΣ ΟΞΕΩΣΗΣ



Γαλακτική οξύωση παρατηρείται συχνά σε καρκινοπαθείς

- Συνήθως οφείλεται σε ↓ καταβολισμό του γαλακτικού οξέος, λόγω ανασταλτικών ουσιών που παράγονται από τα καρκινικά κύτταρα
- Σπανιότερα οφείλεται σε διήθηση και καταστροφή του ήπατος
- Η υπερπαραγωγή γαλακτικού οξέος από τα καρκινικά κύτταρα δεν μπορεί να αποκλειστεί

- Συμπερασματικά, ο ασθενής εμφανίζει L-γαλακτική οξέωση λόγω μείωσης του ρυθμού μεταβολισμού του γαλακτικού οξέος (L-γαλακτική οξέωση τύπου B), συνεπεία της βασικής νόσου του (καρκίνος πνεύμονα με μεταστάσεις)

Ποια είναι η διαταραχή της οξεοβασικής ισορροπίας;

- α. Αναπνευστική οξέωση
- β. L-γαλακτική οξέωση τύπου B
- γ. L-γαλακτική οξέωση τύπου A
- δ. Μεταβολική οξέωση + αναπνευστική αλκάλωση